



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 03-12-2024 14:53:50

Página 1 de 4

Información Paciente

Nombre	: Moisés Modesto Esparza Huerta	Rut	: 9.929.093-5	N° Archivo	: 2319192	N° Epicrisis	
Edad	: 59a 10m 21d	Fecha Nacto	: 12/01/1965	Sexo	: Masculino	422754	
Dirección	: Psje Wilmo 909	Comuna	: Puente Alto	Teléfono	: 978515610		

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso	: Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso	: 03/11/2024	04:26	Días Estadía	: 30
Unidad de Egreso	: Medicina Cuidados Básicos 5° Piso	Fecha Egreso	: 03/12/2024	14:12		

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia - Intoxicación medicamentosa

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS MEDICINA INTERNA

03/12/2024

Nombre: Moises Esparza Huerta

RUT: 9929093-5

Edad: 59 años

FI CASR: 03/11/2024

FI UCI: 03/11/2024

FI UTIM: 20/10/2024

FI Sala: 27/11/2024

ANAMNESIS REMOTA:

AM: HTA, DM2NIR

AQx: (-)

MED: Valsartan, Hidroclorotiazida, Atorvastatina, Metformina

Alergias: (-)

Hábitos: OH crónico 2-2.5L/d

Hospitalizaciones: (-)

MC: Compromiso de conciencia, encontrado por familiares

HISTORIA:

Paciente con antecedentes descritos, encontrado por familiares con compromiso cuali-cuantitativo de conciencia y vómitos en su domicilio. En el lugar encuentran blister vacío de aproximadamente 50 comp metformina, 10 comp hidroclorotiazida + valsartan, él refiere consumo de atenolol además, negó consumo de paracetamol. Familia refiere consumo de OH, 2 latas de cerveza.

Ingres a REA PAM 50 bradicardia 40 HGT 35, ECG bradicardia sinusal. En evaluación primaria destaca llene capilar enlentecido con mottling, se describe consciente acata órdenes simples y sin focalidad grosera. Recibe SG 30%, volemisación

Fecha Epicrisis : 03/12/2024 14:53

Página 1 de 4

con cristaloideos y aportes de gluconato de calcio, además de soporte con NAD. Ingres a UPC para compensación hemodinámica e inicio de VMI el 03/11, descrita Cormack 1.

DIAGNÓSTICOS INGRESO:

1. Intoxicación medicamentosa
 - Intoxicación por metformina
 - Intoxicación por atenolol
 - Intoxicación por hidroclorotiazida
2. Shock mixto - Cardiogenico + Distributivo
3. AKI KDGO 3
4. Intento de autolisis

EVOLUCIÓN EN UPC

- HEMODINÁMICO: Muy grave a su ingreso a UPC con soporte hasta NAD 0.7, AD 0.5 y VP 0.05, uso de atropina intermitente por bradicardia severa asociada y azul de metileno. Además acidosis profunda refractaria a aporte profuso de HCO₃ EV, con requerimiento de TRR continua para manejo tras compensación hemodinámica. Desde el 12/11 inicia destete de soporte vasoactivos, tras resolución de trastornos metabólicos.
- RESPIRATORIO: VMI por falla hemodinámica severa, mantiene VMI desde el 03/11 al 14/11 con salida a BPAP y posterior destete hasta suspensión de aportes.
- METABÓLICO: Intoxicación por metformina, atenolol y valsartán/hidroclorotiazida. En este contexto recibió apoyo con BIC calcio gluconato, IC + SG 30%. Evoluciona con acidosis severa que requirió TRR por refractariedad a medidas.
- PSIQUIATRÍA: Evaluado y en seguimiento por psiquiatría, se determina intoxicación en estado de ebriedad con intencionalidad no clara. Se descarta ideación suicida actual o riesgo inminente de hetero u autoagresión. Inició tiamina
- INFECCIOSO: Cursa NAC de etiología probable aspirativa con identificación de SAMS y S. Pneumoniae, recibió manejo con ampicilina/sulbactam por 7 días con buena respuesta. Posteriormente evoluciona con PPII elevados estacionarios, sin MO aislada en pancultivo o deterioro clínico.
- NEFROLÓGICO: Recibe TRR a su ingreso para manejo de intoxicación por atenolol y AKI KDIGO III, inicialmente SLED, posterior CVVHDF 48hrs desde el 05/11 y HDF en contexto de NTA, logrando adecuada respuesta. Función renal estable con creatinina en torno a 2 en últimos controles con retorno a funcionalidad normal.

Es trasladado a unidad de menor complejidad para rehabilitación.

EVOLUCIÓN EN UTI Y SALA DE MEDICINA:

- HEMODINAMIA: Estable y autosostenida, signos vitales dentro de rango, sin conflicto perfusional.
- RESPIRATORIO: sin requerimientos de O₂ suplementario ni apremio ventilatorio. Se mantiene con KNT.
- INFECCIOSO: Al traslado a UTIM con alza de parámetros inflamatorios y febril. Cultivos 19/11: HC periféricos I y II negativo, UC negativo, Punta CVC negativo. Se inicia manejo ATB empírico con tazonam (FI 20/11), evolucionando con parámetros inflamatorios elevados estacionarios y con peak febriles, por lo que, el 25/11 se repiten cultivos: UC negativo, HC periféricos negativo. Se realiza TC TAP en el cual destaca signos de PNA bilateral. Sedimento urinario inflamatorio (GB 40-50 x campo). Completa tratamiento con tazonam el 28/11, evoluciona asintomático, afebril, PCR en lenta disminución (última previo al alta en 54)
- PSIQUIATRÍA: En seguimiento por equipo de psiquiatría, en última evolución refieren paciente con T. delirante por consumo de OH, sin conciencia de enfermedad ni tratamiento en ambulatorio. Sin riesgo de daño inminente a sí mismo ni a terceros, sugieren derivar al alta a CESFAM para gestionar derivación a COSAM; sin embargo, dada baja probabilidad de controles en APS, se decide IC al alta para control con Psiquiatría en CDT. Dado ansiedad y angustia referida, se ajusta medicación indicada por especialidad: se mantiene risperidona 3 mg y tiamina 300 mg (hasta el alta), se aumenta quetiapina nocturna y se agrega dosis baja de lorazepam nocturno (síntomas de abstinencia leve, CIWA-Ar 3 puntos). El 02/12, evoluciona con CIWA-Ar 1 punto, se decide suspender lorazepam nocturno. Al día del alta, niega síntomas de abstinencia, sin agitación psicomotora. Refiere sentirse en condiciones para continuar controles en ambulatorio.
- SOCIAL: En evoluciones previas de UPC, sin claridad de red de apoyo al alta, se pesquisa VIF, paciente comenta que su familia abandonarán hogar aparentemente con denuncia para protección de menores de edad que vivían en domicilio (hija refiere interponer denuncia contra su padre, expresado verbalmente a Asistente Social); sin embargo, es visitado por hijos y hermana, quienes no se entregan información entre sí. Al interrogatorio actual, información discordante, paciente refiere no comprender problema social, relata buena relación con hijos, pero separación conyugal reciente. Su ex esposa e hija se

Fecha Última Actualización: 03-12-2024 14:53:50

Página 3 de 4

mudarán de su hogar al ser dado de alta. Quedaría a cargo de su hijo que trabaja por turnos en Antofagasta y de su hermana. Se conversa con su hermana (Susana) y se acuerda alta a su domicilio para otorgar los cuidados necesarios en rehabilitación y acompañamiento.

- NEFRO/MEDIO INTERNO: Requirió hemodiálisis en contexto de intoxicación medicamentosa, posteriormente con creatinina en mejoría (última previo al alta 1.3), diuresis conservada, sin alteraciones HE.

- REHABILITACIÓN: Paciente con paraparesia M4, Obs polineuropatía del paciente crítico. Buena progresión en rehabilitación, al día del alta con fuerza M5 EEII proximal. Continuar kinesioterapia para eventualmente lograr deambulacion sin ayudas técnicas (actualmente con andador). Se entrega receta de andador móvil a Asistente Social para gestión de ayudas técnicas (fuera de canasta GES). Se mantiene pregabalina por dolor neuropático y alteraciones sensitivas en ambas EEII.

- REUMATOLÓGICO: Se rescata antecedente de diagnóstico de Gota. El 29/11 con cuadro compatible con Gota aguda. Se inicia tratamiento con colchicina y AINES, buena respuesta. Se rescata antecedente de 4 episodios en el último año. Se controla ácido úrico: normal (5.5). Refiere antecedente de litiasis renal hace años, con eliminación espontánea por la orina, sin clínica de cólico renal. Dado 4 episodios en el año, se decide iniciar tratamiento crónico con hipouricemiantes y control médico en 1 mes.

ÚLTIMO LABORATORIO:

02/12: Hb 9.4, Hto 28.1, VCM 87, CHCM 33, GB 6.64, plaq 233, PCR 54.6, crea 1.34, BUN 23.9, ELP 138/3.71/110, Ca 8.8, Alb 2.7, P 4.5, Mg 1.6, LDH 175, AU 5.5. GSV: pH 7.37, pCO2 29, HCO3 16.7. GOT 18, GPT 27, GGT 148, FA 137, BiliT 0.44, BiliD 0.24

28/11: PCR 59.6, Crea 1.54, BUN 25.1, ELP 138/3.74/109

27/11: Hb 9.6 (9.8), Hto 29.2, VCM 88.8, CHCM 32.9, GB 6.41, plaq 242, PCR 69.8, crea 1.7 (previa 1.7), BUN 27.5, ELP 138/4.02/110, Ca 8.9, Mg 1.6, P 4, GSV pH 7.39, pCO2 30, HCO3 18.1. TP 92% INR 0.98, TTPA 25.6

ÚLTIMA IMAGEN:

26/11 TC TAP: Mínimo derrame pleural bilateral. Hallazgos tomográficos sugerentes de pielonefritis bilateral, de probable etiología inflamatoria - infecciosa. Correlacionar con pruebas de orina. Diverticulosis colónica, sin signos tomográficos de diverticulitis aguda actual.

DIAGNÓSTICOS DE EGRESO

1) Ingesta medicamentosa con intención indeterminada ¿ Obs int e n t o de suicidio

a. Intoxicación por Metformina, Valsartán/Hidroclorotiazida y Atenolol

2) Falla multiorgánica, resuelta

a. Shock distributivo refractario, resuelto

b. Insuficiencia respiratoria aguda parcial, resuelta

c. AKI KDIGO III con requerimiento transitorio de TRR, resuelta

- CVVHDF 05-07/11

- SLED 08/11

d. Alteración de perfil hepático patrón mixto, resuelto

e. Compromiso de conciencia, resuelto

f. Coagulopatía, resuelta

3) Acidosis metabólica severa resuelta

4) NAC Obs. aspirativa por SAMS y Neumococo, tratada

5) PNA Bilateral tratada

a. Sin microorganismo aislado, tratamiento empírico con piperacilina/tazobactam (FI 20/11)

6) Gota aguda - artritis gotosa, resolución

7) Antecedentes: DM Tipo 2 NIR. HTA

Diagnóstico de Egreso

ENVENENAMIENTO AUTOINFLIGIDO INTENCIONALMENTE POR, Y EXPOSICIÓN A OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLÓGICAS, Y A LOS NO ESPECIFICADOS, OCURRIDOS EN OTRO LUGAR ESPECIFICADO - 1)

Ingesta medicamentosa con intención indeterminada ¿ Obs intent o de suicidio

a. Intoxicación por Metformina, Valsartán/Hidroclorotiazida y Atenolol

Fecha Epicrisis : 03/12/2024 14:53

Página 3 de 4

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J: NO

Moises en buenas condiciones generales, hemodinamia estable y autosostenida, signos vitales dentro de rango, buena perfusión clínica, sin requerimiento de O2 adicional ni apremio ventilatorio. Afebril. Cooperador.

Niega dolor torácico, disnea, palpitaciones, dolor abdominal, síntomas gastrointestinales o genitourinarios. Niega persistencia de síntomas de gota en ambos tobillos y primera articulación metatarsal-falángica bilateral. Respecto a paraparesia iniciada durante la hospitalización, en franca regresión, con fuerza M5 bilateral EEII. Deambulando con andador.

Plan Post Alta

INDICACIONES AL ALTA

GENERALES:

- Reposo relativo, no guardar cama. Asistir en actividades de deambulación, dado alto riesgo de caídas. Deambular con andador móvil, incentivar progresivamente a deambular con bastones, para luego caminar sin ayudas técnicas.
- Continuar con rehabilitación motora con Kinesioterapia (10 sesiones) en CESFAM correspondiente.
- Régimen hiposódico (bajo en sal) y diabético (bajo en carbohidratos).

FÁRMACOS:

- Omeprazol 20 mg: 1 comprimido en ayuno en la mañana, vía oral, por 2 semanas.
- Risperidona 1 mg: 3 comprimidos en la noche, vía oral, hasta control médico con Psiquiatra
- Quetiapina 25 mg: 1 comprimido en la noche, vía oral, hasta control médico con Psiquiatra
- Pregabalina 75 mg: 1 comprimido en la noche, vía oral
- Colchicina 0.5 mg: 1 comprimido cada 12 horas, vía oral, hasta el 07/12 inclusive.
- Alopurinol 100 mg: 1 comprimido al día, vía oral por 1 mes. INICIAR MEDICAMENTO 2 SEMANAS POSTERIOR A TERMINAR TRATAMIENTO CON COLCHICINA. Asociar Colchicina 0.5 mg: 1 comprimido al día por 1 mes (profilaxis asociada a fármaco hipouricemiante)
- Paracetamol 500 mg: 2 comprimidos cada 8 horas, vía oral, en caso de dolor
- Ibuprofeno 400 mg: 1 comprimido cada 8 horas, vía oral, en caso de dolor tipo gota, por un máximo de 3 días.

CONTROLES

- Se realiza IC a Psiquiatría para control con especialidad. Solicitar hora en CDT
- Solicitar hora médica en CESFAM con equipo de Salud Mental para ingresar a Programa de Salud Mental y continuar seguimiento médico y con psicología.
- Solicitar hora médica en CESFAM en 1 mes para control de gota y evaluar continuidad de tratamiento
- Solicitar hora con Kinesiología en CESFAM para continuar terapia de rehabilitación (polineuropatía del paciente crítico). Total 10 sesiones.

Indicaciones

Tipo de Reposo : Relativo

Régimen Alimentario : Hiposódico

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente


Alberto Sarfatis Feige
Médico Tratante (Staff)